

Consentimiento Informado DIU Mirena

Versión: v1.0

Datos del Consentimiento

Fecha de generación:

09/05/2026 17:17

Estado:

Completado

Contenido del Consentimiento

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA COLOCACIÓN (DIU) HORMONAL MIRENA

Manifiesto que he sido informada de manera clara, comprensible sobre el dispositivo intrauterino hormonal Mirena como método de planificación familiar, y que comprendo lo siguiente :

DESCRIPCIÓN DEL DIU MIRENA Y SU FUNCIONAMIENTO

Mirena es un dispositivo intrauterino (DIU) hormonal en forma de "T" hecho de plástico, que se coloca dentro del útero. Contiene la hormona levonorgestrel, la cual se libera lentamente en pequeñas cantidades dentro de la cavidad uterina. Esta hormona engrosa el moco cervical y adelgaza el revestimiento del útero, impidiendo el paso de los espermatozoides y dificultando la fertilización del óvulo

En algunas mujeres, Mirena también puede inhibir la ovulación.

El efecto anticonceptivo dura alrededor de 5 años, después de lo cual el DIU debe ser retirado o reemplazado por uno nuevo para seguir protegiendo contra el embarazo. Si en algún momento antes de ese plazo se desea discontinuar el método, el DIU puede ser retirado, y la fertilidad usualmente retorna rápidamente tras su extracción.

Este método no protege contra infecciones de transmisión sexual (ITS), por lo que se recomienda usar condón si se requiere proteger contra las ITS.

EFECTIVIDAD Y TASAS DE FALLA

Se me ha recalcado que ningún método anticonceptivo ofrece una efectividad del 100%. En el caso del DIU Mirena, su eficacia es muy alta pero no absoluta. La tasa de fracaso (probabilidad de embarazo) estimada del Mirena es de alrededor del 0.2% en el primer año de uso

(aproximadamente 2 de cada 1,000 mujeres quedan embarazadas en el primer año pese a usarlo correctamente), y la tasa de falla acumulada a 5 años ronda el 0.7%

En otras palabras, más del 99% de las usuarias no tendrán un embarazo durante cada año de uso del DIU, lo que lo hace uno de los métodos anticonceptivos más efectivos disponibles. A pesar de esta alta eficacia, entiendo que existe una pequeña posibilidad de embarazo mientras use el DIU, por lo que si alguna vez sospecho estar embarazada (por ausencia prolongada de menstruación o síntomas de embarazo) debo informar de inmediato al médico para descartar o atender esa situación. Asimismo, reitero comprender que el DIU Mirena no previene las enfermedades de transmisión sexual, por lo que si tengo riesgo de contraer una ITS se recomienda el uso adicional de métodos de barrera como el condón.

CUIDADOS POSTERIORES, REVISIONES Y RECOMENDACIONES

Se me ha informado sobre la importancia del seguimiento médico después de la colocación del DIU Mirena:

Revisiones periódicas: Debo acudir a una revisión médica aproximadamente 1 mes después de la inserción para verificar que el DIU esté correctamente colocado y que no haya signos de complicaciones o infección. Posteriormente, se sugiere una revisión a los 6 meses de uso y luego chequeos anuales mientras tenga el dispositivo, a menos que surja alguna molestia antes. En cada visita de seguimiento el profesional de salud comprobará que los hilos del DIU estén visibles y que el dispositivo permanezca en buena posición.

Autocuidado: Me han enseñado cómo palpar los hilos del DIU en la vagina (introduciendo con cuidado un dedo en profundidad hasta el cuello uterino) para confirmar que el DIU sigue en su lugar. Se me indicó hacer esta verificación de forma periódica (por ejemplo, una vez al mes), preferiblemente después de cada menstruación. Si en algún momento no logro sentir los hilos o los noto más largos de lo habitual (lo cual podría indicar desplazamiento), o si presento síntomas de alarma como dolor abdominal intenso, cólicos inusuales, sangrado abundante repentino o cualquier otra señal fuera de lo común, debo acudir inmediatamente a consulta médica para evaluación.

Advertencias: También debo buscar atención médica de inmediato si sospecho de embarazo o si presento signos de infección (por ejemplo, flujo vaginal con mal olor, dolor pélvico persistente, fiebre). Entiendo que no debo intentar retirarme el DIU por cuenta propia; la extracción debe hacerla un profesional capacitado. Ante cualquier duda sobre el uso del DIU Mirena, tengo el derecho de consultar a mi médico o personal de salud, quienes responderán a mis preguntas.

BENEFICIOS DEL DIU MIRENA COMO MÉTODO ANTICONCEPTIVO

Se me ha explicado que el DIU Mirena ofrece varios beneficios:

Alta eficacia anticonceptiva: Es un método con más del 99% de efectividad para prevenir el embarazo. Esto significa que la tasa de falla es muy baja.

Larga duración y comodidad: Proporciona protección prolongada (hasta 5 años de eficacia anticonceptiva) sin necesidad de recordar tomar una píldora diariamente ni de usar un método en cada relación sexual. Es un método cómodo, ya que una vez colocado uno no tiene que hacer algo antes de cada relación sexual para estar protegida.

Reversibilidad: Es un método temporal; puede retirarse en cualquier momento si así lo deseo, y la capacidad para embarazarme regresa casi de inmediato tras la retirada del DIU.

Beneficios menstruales: Mirena suele hacer que las menstruaciones sean más leves y menos dolorosas con el tiempo. Después de los primeros meses de uso, el sangrado menstrual mensual típicamente disminuye e incluso puede llegar a ausentarse en algunas mujeres. Aproximadamente 2 de cada 10 usuarias dejan de tener menstruación al cabo de un año de uso, lo cual puede ser beneficioso para quienes sufren de sangrados abundantes o anemia (la ausencia de menstruación bajo este método no es dañina para la salud). Además, la reducción de sangrado y la acción de la hormona pueden disminuir cólicos menstruales y contribuir a mejorar condiciones como la menstruación muy abundante.

Otras ventajas: La presencia del DIU en el útero también puede aportar cierta protección contra la hiperplasia endometrial (crecimiento excesivo del revestimiento uterino) y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria al espesar el moco cervical. También es seguro durante la lactancia (aunque en mujeres amamantando muy recientes se observa un riesgo ligeramente mayor de ciertas complicaciones, mencionado más adelante).

POSIBLES RIESGOS, EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES

Entiendo que, como todo método anticonceptivo, el DIU Mirena conlleva posibles riesgos y efectos adversos que me han sido explicados. Estos incluyen:

Sangrados irregulares: Es común presentar irregularidades en el sangrado menstrual durante los primeros meses tras la inserción. Puede haber manchado ligero intermenstrual o variaciones en la duración e intensidad de los periodos. Por lo general, estos cambios mejoran después de 3 a 6 meses de uso conforme el cuerpo se adapta.

Dolor pélvico o cólicos: Puedo experimentar dolor tipo cólico en la pelvis o bajo vientre, especialmente durante o inmediatamente después de la colocación del DIU y en las primeras semanas.

Este dolor suele ser temporal y manejable con analgésicos comunes; generalmente disminuye con el paso del tiempo. Cambios en el estado de ánimo: Algunas usuarias han reportado cambios de humor o episodios de ánimo depresivo/irritabilidad asociados al efecto hormonal del dispositivo. No todas las personas experimentan esto, pero es una posibilidad a tener en cuenta.

Dolor de cabeza (cefalea): Es posible presentar cefaleas o dolores de cabeza como efecto secundario del método.

Acné u otros cambios en la piel: La hormona liberada puede ocasionar acné o aumento de la grasa en la piel en algunas personas.

Sensibilidad mamaria: Puedo notar los senos más sensibles o dolorosos (dolor mamario) durante los primeros meses de uso. Esto generalmente disminuye tras los primeros meses.

Ausencia de menstruación: Como se mencionó, es posible que con el uso prolongado mis periodos se vuelvan muy escasos o incluso desaparezcan (amenorrea). Esto no causa daño, pero debo estar consciente de ello para que no me tome por sorpresa.

Expulsión del DIU: Existe el riesgo de expulsión parcial o total del dispositivo. Esto significa que el DIU podría desplazarse de su posición o salirse del útero espontáneamente. Aunque es poco frecuente, puede ocurrir sobre todo en los primeros meses tras la inserción o durante la menstruación, y es más probable si recientemente hubo un parto o si la paciente nunca ha estado embarazada previamente. La expulsión puede ser asintomática (sin que yo me dé cuenta de inmediato) o manifestarse con síntomas como aumento del sangrado uterino o cólicos intensos inusuales. Si el DIU se desplaza o expulsa, su eficacia anticonceptiva disminuye o se pierde, y sería necesario retirarlo o reemplazarlo. Se me indicó que, de sospechar que el DIU se ha movido (por ejemplo, si dejo de sentir los hilos o presento los síntomas mencionados), debo acudir al médico de inmediato.

Infección pélvica: La inserción de cualquier DIU conlleva un riesgo bajo de infección en el tracto genital (endometritis o enfermedad pélvica inflamatoria). Este riesgo es mayormente limitado a las primeras semanas después de la colocación, especialmente si existiera alguna infección de transmisión sexual no tratada al momento de insertar el DIU. Para minimizar este riesgo, el procedimiento se realiza bajo condiciones de asepsia, y suele descartarse la presencia de infecciones antes de la inserción. En caso de presentarse una infección uterina o pélvica, podría requerir tratamiento antibiótico e incluso la remoción del dispositivo si la infección no cede.

Perforación uterina: En casos raros, el DIU podría perforar la pared del útero durante el procedimiento de inserción. Esta es una complicación poco común (aproximadamente ocurre en 1 de cada 1,000 inserciones) pero potencialmente seria. De suceder una perforación, el dispositivo podría desplazarse a la cavidad abdominal y sería necesario retirarlo mediante un procedimiento quirúrgico. El riesgo de perforación puede ser ligeramente mayor si el DIU se coloca poco tiempo después del parto o durante la lactancia.

Embarazo ectópico: Entiendo que ningún método es 100% efectivo, y aunque es extremadamente improbable quedar embarazada usando Mirena, si llegase a ocurrir un embarazo existe mayor probabilidad de que sea ectópico, es decir, un embarazo fuera del útero (por ejemplo en la trompa de Falopio). Un embarazo ectópico es una condición médica seria que requiere atención inmediata. Sin embargo, también comprendo que dado que el Mirena previene la gran mayoría de los embarazos, el riesgo absoluto de embarazo ectópico en usuarias de DIU es mucho más bajo que en mujeres sexualmente activas sin ningún método anticonceptivo.

Otras posibles molestias: En casos aislados, se han observado quistes ováricos funcionales en usuarias de DIU hormonal; estos generalmente no causan síntomas importantes y tienden a resolverse espontáneamente en pocos meses. Igualmente, pueden presentarse mareos o desmayos pasajeros durante o inmediatamente después de la

inserción del DIU (a causa de una reacción vaso-vagal por el procedimiento), los cuales remiten rápidamente. Cualquier síntoma inusual será evaluado y manejado por el profesional de salud.

4. ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

El DIU no protege contra enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Es fundamental acudir a controles médicos y estar atenta a señales de alerta como dolor intenso, fiebre, flujo vaginal anormal o sangrado abundante.

Informar si se tiene antecedente de enfermedades pélvicas, infecciones recurrentes o condiciones médicas específicas.

BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Declaro que:

Alternativas y decisión libre: Mi médico/profesional de salud me ha informado sobre las opciones anticonceptivas disponibles (incluyendo métodos temporales y definitivos, hormonales y no hormonales), explicándome las ventajas y desventajas de cada uno. Después de recibir esta información y resolver todas mis dudas, he elegido de manera libre, informada y voluntaria el método DIU hormonal Mirena como mi opción de planificación familiar en este momento, por considerarlo el más adecuado a mis necesidades y preferencias.

Comprensión de la información: Declaro que he entendido la explicación que se me proporcionó en un lenguaje claro y accesible sobre qué es el DIU Mirena, cómo funciona, sus beneficios, posibles riesgos, efectos secundarios y cuidados necesarios. He tenido la oportunidad de hacer preguntas, las cuales fueron respondidas de forma satisfactoria y completa por parte de mi médico/profesional de salud. Toda la información recibida la comprendo en su alcance y consecuencias.

Consentimiento voluntario: Después de analizar la información y aclarar mis dudas, otorgo mi consentimiento para que se me realice la inserción del DIU hormonal Mirena como método anticonceptivo. Entiendo que este procedimiento se llevará a cabo por personal de salud calificado, bajo las condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Confirmando que tomo esta decisión sin haber sido presionada por nadie y ejerciendo mi derecho a decidir sobre mi salud reproductiva de manera autónoma, de acuerdo con la legislación y principios bioéticos vigentes en México. Asimismo, comprendo que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento, es decir, puedo solicitar que se retire el DIU cuando yo lo desee o negarme a continuar con su uso, y que dicha decisión será respetada sin que ello afecte la calidad de la atención médica que reciba.

DECLARACIÓN DEL MÉDICO

Como médico responsable, he proporcionado a la paciente información clara y completa sobre el procedimiento, los riesgos, beneficios y alternativas, y he respondido a todas sus preguntas.

Paciente

Nombre completo:

Liliana Esquivel Rivera

Médico Responsable

Nombre:

Erika Bellos Jimenez

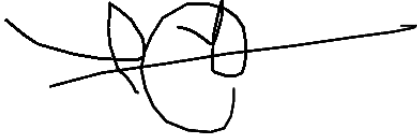
Firmas



Paciente: Liliana Esquivel Rivera
09/05/2026 17:18



Medico: Erika Bellos Jimenez
09/05/2026 17:18



Testigo 1: Jesus Lopez Velazquez
09/05/2026 17:18



Testigo 2: Mario Lopez Urbina
09/05/2026 17:18